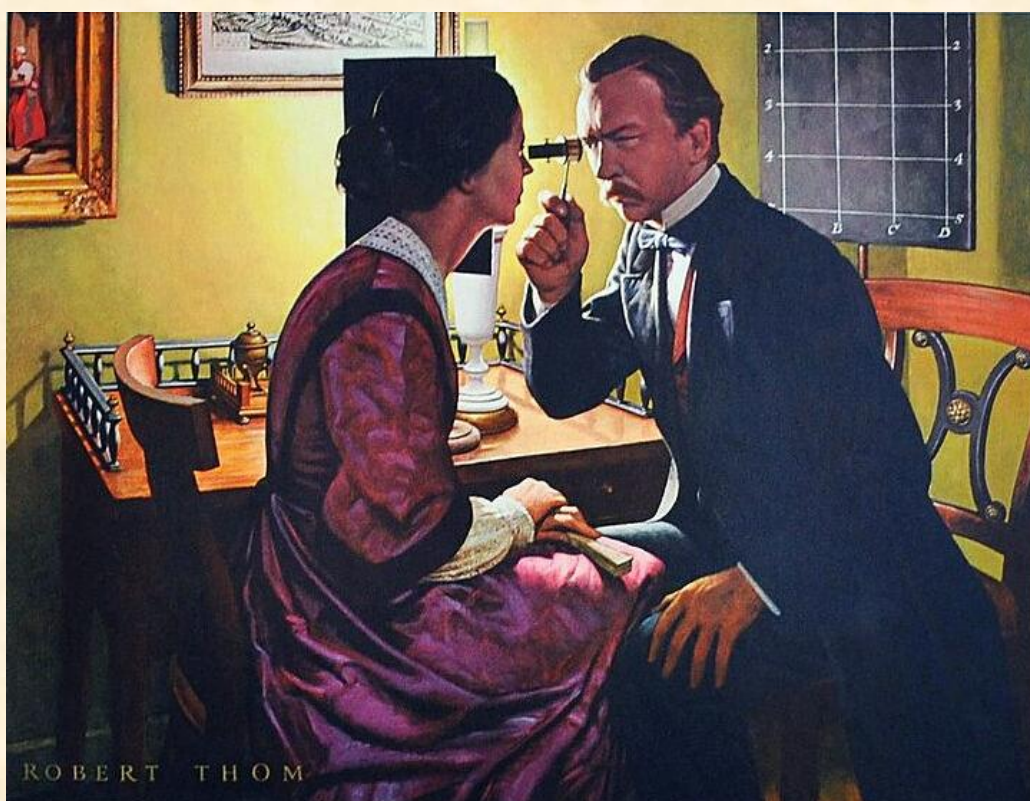


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15^ο

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ



«Οφθαλμοί γαρ των ώτων ακριβέστεροι μάρτυρες».

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ.

ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ – ΕΓΚΑΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Ιστορικό - Αίτια: Τα θερμικά τραύματα-εγκαύματα του κερατοειδούς οφείλονται συνήθως σε πυρακτωμένα αλλότρια σώματα, τα οποία εκσφενδονίζονται προς το μάτι, ήτοι καύτρα σπίρτου ή κάρβουνου, στάχτη τσιγάρου, σπινθήρας ηλεκτροκόλλησης, κ.ά.

Συμπτώματα: Επειδή η πυκνότητα των υποδοχέων πόνου (οφθαλμικοί κλάδοι τριδύμου) στον κερατοειδή χιτώνα είναι 300-500 φορές μεγαλύτερη από ό,τι στο δέρμα, για αυτό το κύριο σύμπτωμα των κακώσεων του κερατοειδούς είναι ο έντονος ή αφόρητος πόνος, ενώ συνήθως συνυπάρχει δακρύρροια, βλεφαρόσπασμος, φωτοφοβία, μείωση οπτικής οξύτητας εξαιτίας των επιθηλιακών ελλειμμάτων, θόλωση κερατοειδούς και επακόλουθη φλεγμονή, διάτρηση του κερατοειδούς ή και αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση.

Συνήθως τα θερμικά τραύματα του οφθαλμού αφορούν στις επιφανειακές στοιβάδες του κερατοειδούς, προκαλώντας απόπτωση του επιθηλίου.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Διενεργούμε πλύσεις με άφθονο φυσιολογικό ορό (NaCl 0,9%) ή Ringer's Lactate (R/L) και απομακρύνουμε προσεκτικά τυχόν υπολείμματα ξένων σωμάτων.
2. Ενσταλλάσσουμε 2-3 σταγόνες κολλυρίου **Alcaine** ή **Tetracaine 0,5%**, για αναλγησία στον βολβό και για να διευκολυνθούμε στους μετέπειτα χειρισμούς επί του οφθαλμού.
3. Με ειδικό σπέρτο **Φλουοροσκεΐνης** επαλείφουμε την έσω επιφάνεια των βλεφάρων και τους επιπεφυκότες, αναμένουμε για 1-2 λεπτά και έπειτα ξεπλένουμε με 10-20 ml N/S. Απομακρύνουμε προσεκτικά με έναν βαμβακοφόρο στείλει τα υπολείμματα του ξένου σώματος που είναι πλέον ορατά, όπως και οι κακώσεις του κερατοειδικού επιθηλίου που φθορίζουν κιτρινοπράσινα στο κυανό φίλτρο φωτός του οφθαλμοσκοπίου (βλ. εικόνες). Αν πρόκειται για ενσφηνωμένα ρινίσματα μετάλλου πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδικός μαγνητικός στείλει Hilbro για την αβλαβή απομάκρυνσή τους από τον κερατοειδή.
4. Αφού πλύνουμε ξανά, καλά, ενσταλάζουμε 1-2 σταγόνες κολλυρίου **Tobrex** ή **Tobradex**.
5. Μπορούμε να ενσταλλάξουμε επίσης επικουρικά ένα λιπαντικό οφθαλμικό διάλυμα με αντιοξειδωτική και ενυδατική δράση, για την ανακούφιση της ξηροφθαλμίας και των οφθαλμικών ενοχλήσεων. Έτσι, χορηγούμε coll. **Thealoz Duo** (με Υαλουρονικό νάτριο και Τρεχαλόζη 3%) ή coll. **Navitae** (με Υαλουρονικό νάτριο και βιταμίνες Α και Ε). Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί γέλη **Dexpantenol 5% (Corneregel ή Recugel)** σε δοσολογία 1-2 σταγόνες 3-5 φορές ημερησίως, στο κάτω βλέφαρο, όλα για 5-7 ημέρες.
6. Ενσταλάζουμε στον πάσχοντα οφθαλμό 1-2 σταγόνες κολλυρίου Φαινυλαιφρίνης 5%. Προκαλεί συστολή των αγγείων του επιπεφυκότα άμεσα και διάρκειας 2-4 ωρών.
7. Καλύπτουμε τον προσβεβλημένο οφθαλμό με ειδικό επίδεσμο (*eye pad*) για 5-7 ημέρες και ενσταλάζουμε 1-2 σταγόνες coll. Tobrex ή Tobradex κάθε 8 ώρες, για 7-10 ημέρες. Κατά τη βραδινή δόση, μπορεί να χορηγηθούν εναλλακτικά ή επιπρόσθετα 2 σταγόνες κολλυρίου **Errkes** (Κετορολόκη 0,5%), για αναλγησία και μείωση της φλεγμονής.
8. Παραπομπή, άμεσα, σε οφθαλμίατρο ή σε νοσοκομείο, ειδικά αν ο τραυματισμός είναι πολύ σοβαρός και τα συμπτώματα επιμένουν πέραν των 48 ωρών ή επιδεινώνονται. Στις πλέον σοβαρές περιπτώσεις βλαβών, όπου πιθανώς εμφανίζονται παραμορφώσεις και των βλεφάρων ή/και των πέριξ του οφθαλμού περιοχών, συστήνεται στον ασθενή η διενέργεια - σε δεύτερο χρόνο - επέμβασης πλαστικής χειρουργικής αποκατάστασης.

